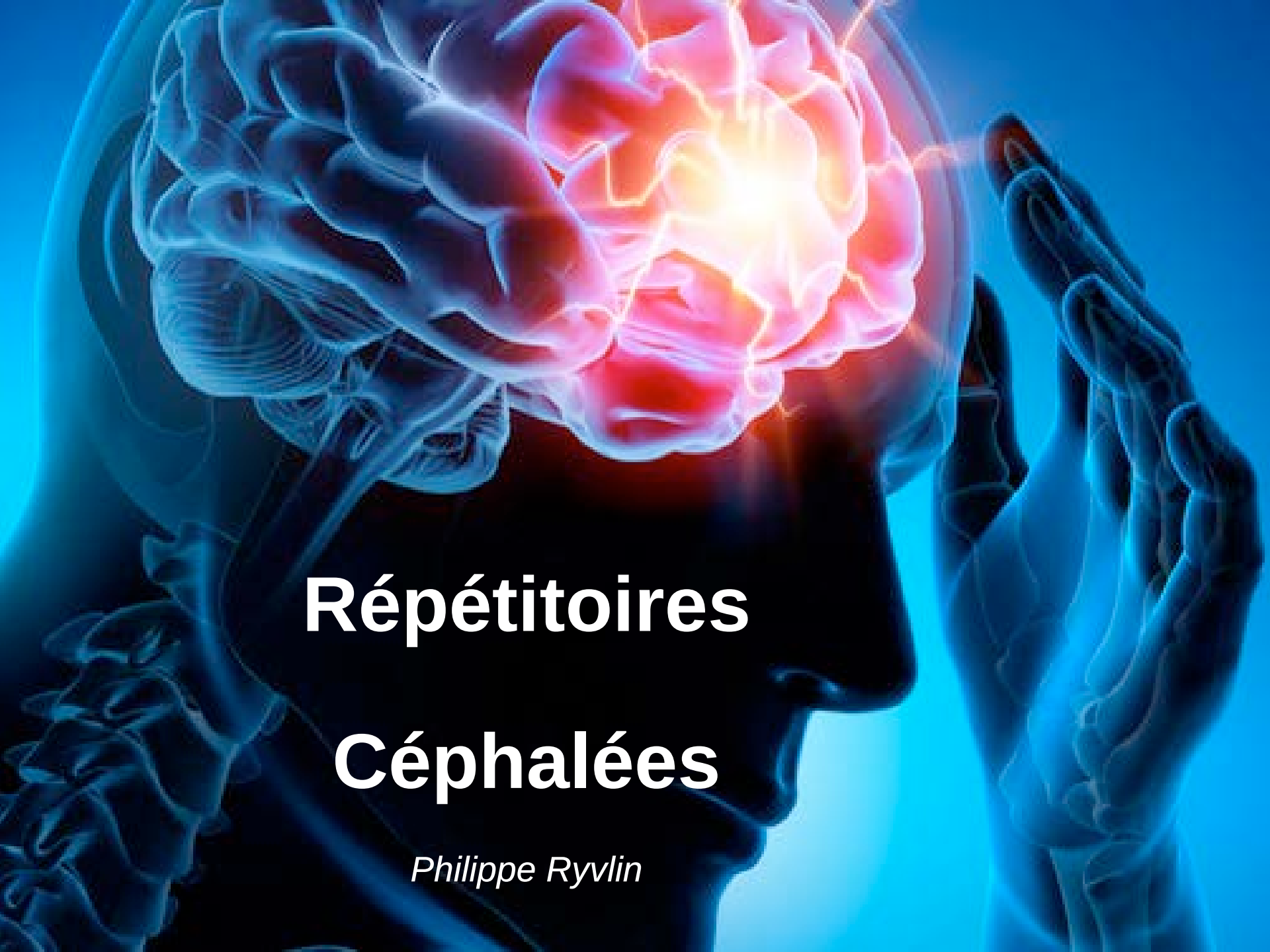




Répétitoires Céphalées

Philippe Ryvlin

Céphalée et signe oculaire



Cas n°1

Mme L., 35 ans, aux antécédents de migraine commune, consulte aux urgences pour une céphalée inhabituelle, notamment plus intense qu'à l'accoutumée. Elle s'associe à des nausées et des vomissements, et prédomine à droite. L'examen des pupilles révèle une anisochorie, avec une pupille gauche plus petite que celle de droite. Le réflexe photomoteur est aboli à droite. Quelle hypothèse retenez vous:

Cas n°2

A) Syndrome de Horner gauche lié à une crise de migraine

B) Syndrome de Horner gauche par dissection carotidienne droite

Cas n°3

C) Syndrome de Horner droit par dissection carotidienne gauche

D) Atteinte intrinsèque de la 3ème paire crânienne à droite liée à un anévrisme de la carotide droite

E) Glaucome à angle fermé de l'oeil droit

Céphalée et signe oculaire



Cas n°1

Mme L., 35 ans, aux antécédents de migraine commune, consulte aux urgences pour une céphalée inhabituelle, notamment plus intense qu'à l'accoutumée. Elle s'associe à des nausées et des vomissements, et prédomine à droite. L'examen des pupilles révèle une anisochorie, avec une pupille gauche plus petite que celle de droite. Le réflexe photomoteur est aboli à droite. Quelle hypothèse retenez vous:

Cas n°2

A) Syndrome de Horner gauche lié à une crise de migraine

B) Syndrome de Horner gauche par dissection carotidienne droite

Cas n°3

C) Syndrome de Horner droit par dissection carotidienne gauche

D) **Atteinte intrinsèque de la 3ème paire crânienne à droite liée à un anévrisme de la carotide droite**

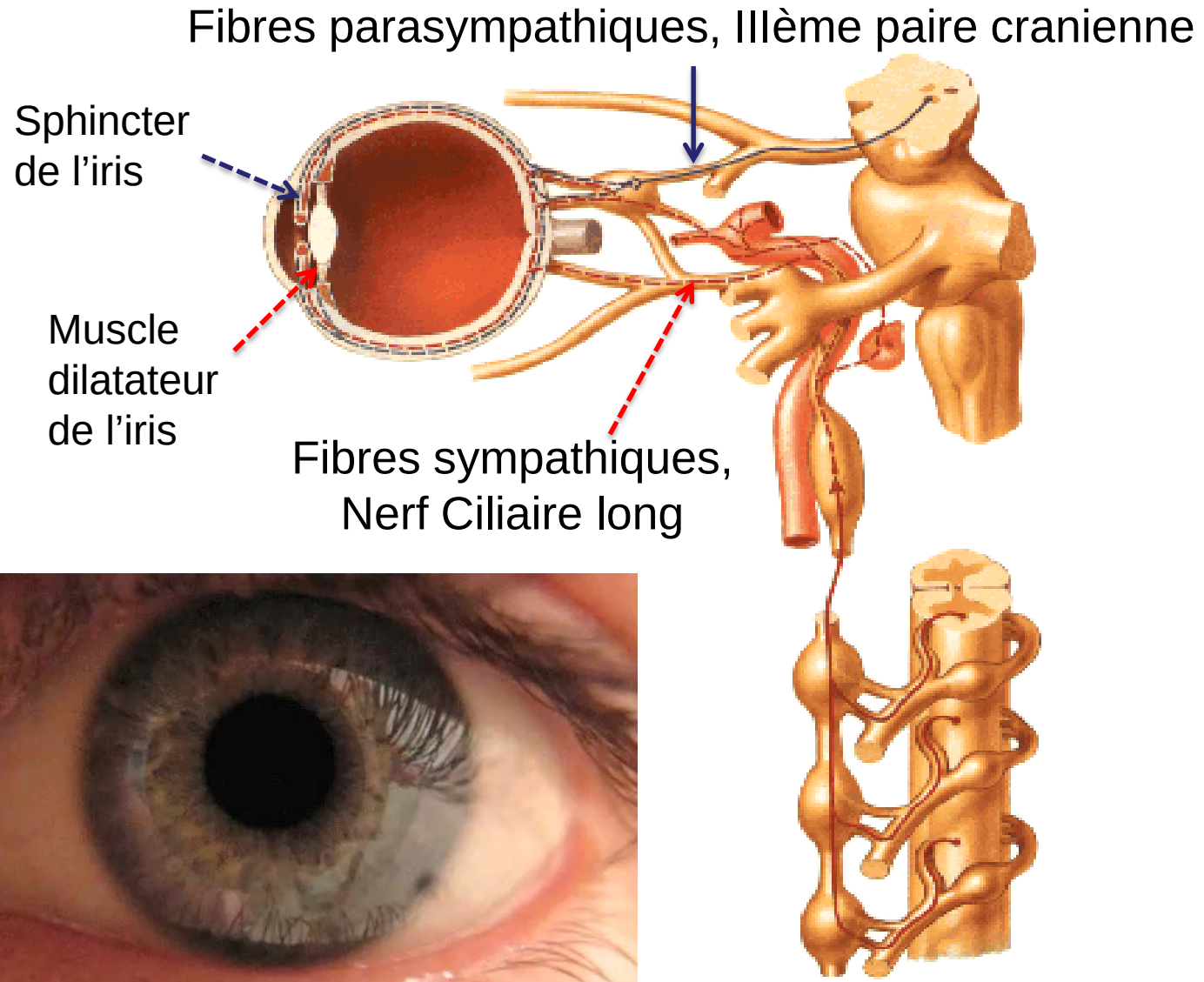
E) Glaucome à angle fermé de l'oeil droit

Céphalée et signe oculaire

Cas n°1

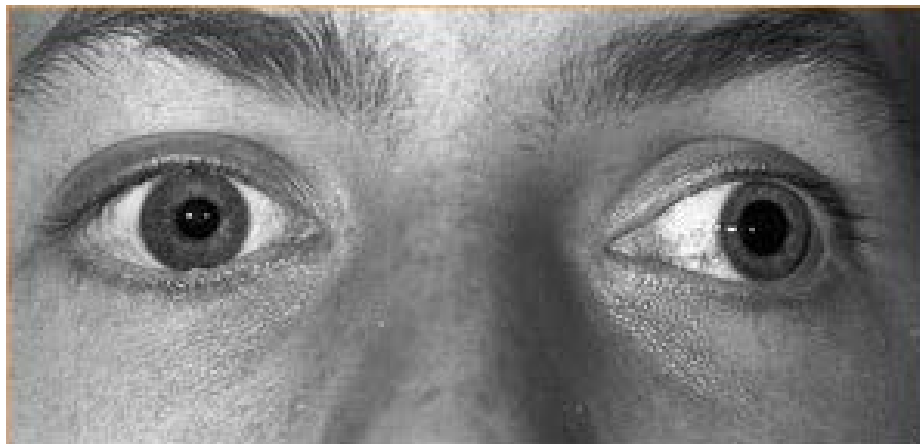
Cas n°2

Cas n°3



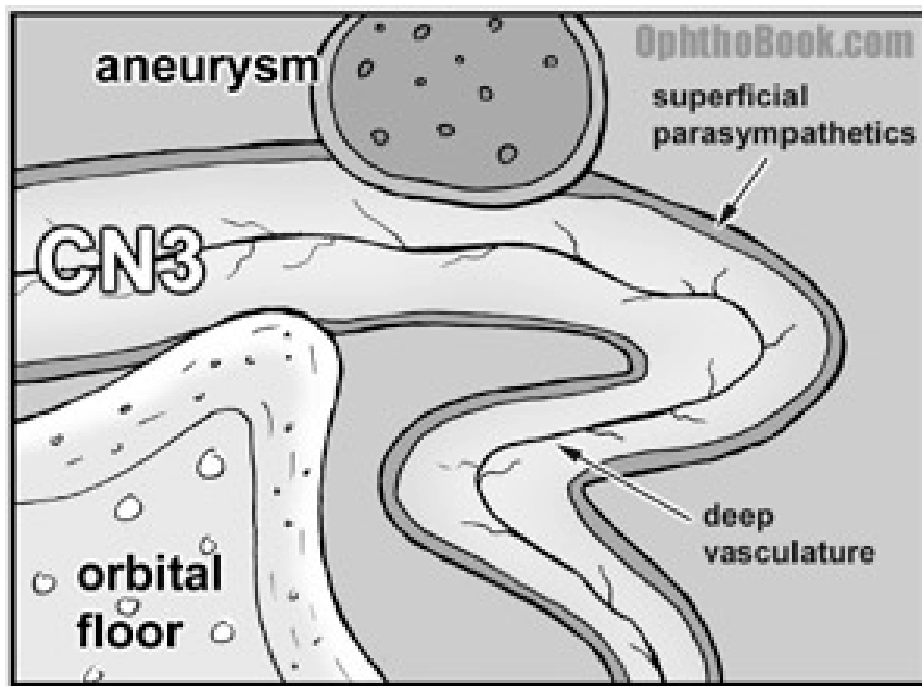
Céphalée et signe oculaire

Cas n°1

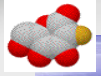


Cas n°2

Cas n°3



Céphalée et signe oculaire

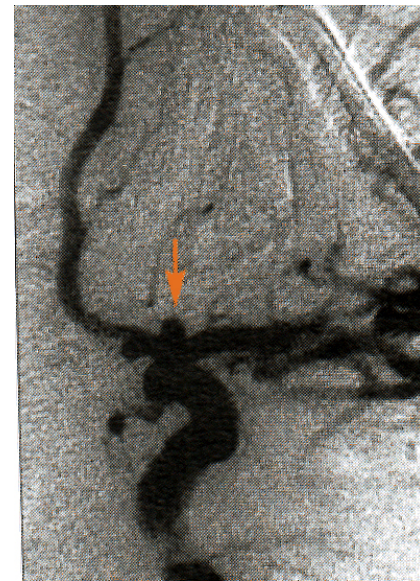
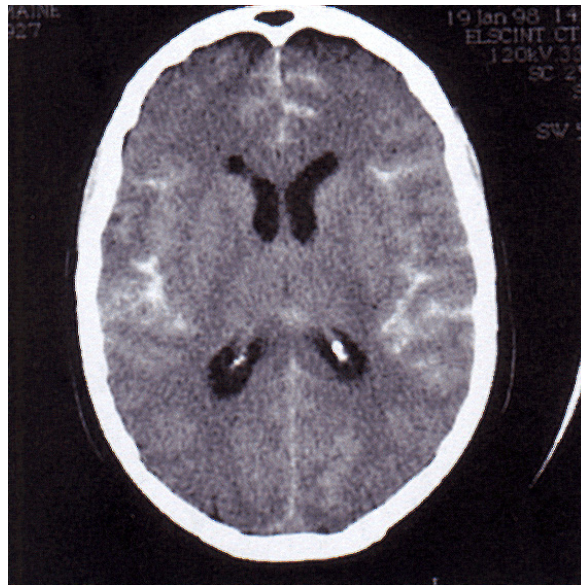


Cas n°1

Cas n°2

Cas n°3

Hémorragie sous arachnoïdienne



70% se présentent avec céphalée isolée
50% des cas : céphalée maximale en < 1 min.
85% de ruptures d'anévrisme

Drapeaux rouges



Cas n°1

CONTEXTE

- ◆ **Grossesse, post-partum**, début > 50 ans
- ◆ **HIV+**, immuno-suppression, anticoagulation, cancer, perte de poids
- ◆ Manipulation/traumatisme **nuque** ou crâne

CARACTERISTIQUES CEPHALEE

- ◆ Céphalée **nouvelle** ou **différente** : *localisation, durée, intensité ...*
- ◆ Céphalée décrite comme **la pire**
- ◆ Céphalée en **coup de tonnerre** = **explosive** (*max < 60 sec.*)
- ◆ Céphalée déclenchée par l'**effort**, l'exercice, l'activité sexuelle
- ◆ Céphalée déclenchée/aggravée par le **Valsalva** ou **positionnelle**

AUTRES ELEMENTS CLINIQUES

- ◆ Symptômes neurologiques **récents inhabituels**
- ◆ Douleurs des **ceintures** et/ou **claudication de la mâchoire** et/ou myalgie et/ou sensibilité temporale
- ◆ Présence d'anomalie à l'**examen neurologique**
- ◆ **Rash** et/ou **méningisme**
- ◆ Etat **fébrile** inexpliqué
- ◆ **Hypertension** sévère $\geq 180/120$



Cas n°2

Cas n°3



Céphalées récurrentes



Cas n°1

Mlle M., âgée de 25 ans consulte pour des céphalées habituelles évoluant depuis l'âge de 14 ans, mais devenues plus fréquentes depuis un changement de contraception il y a 3 mois. Ses douleurs évoluent par crises, en général à début postérieur latéralisé (droit ou gauche) et pulsatiles. Elles l'empêchent de travailler car le bruit et la lumière les renforcent. La durée des crises est de 6 à 12 heures, et leur fréquence de 1 à 2 par semaines. Quel diagnostic retenez vous ?

Cas n°2

- A) Migraine épisodique sans aura
- B) Migraine chronique favorisée par la contraception
- C) Céphalées de tension d'origine cervicale
- D) Céphalées symptomatique d'un processus expansif
- E) Trouble fonctionnel

Cas n°3



Céphalées récurrentes



Cas n°1

Mlle M., âgée de 25 ans consulte pour des céphalées habituelles évoluant depuis l'âge de 14 ans, mais devenues plus fréquentes depuis un changement de contraception il y a 3 mois. Ses douleurs évoluent par crises, en général à début postérieur latéralisé (droit ou gauche) et pulsatiles. Elles l'empêchent de travailler car le bruit et la lumière les renforcent. La durée des crises est de 6 à 12 heures, et leur fréquence de 1 à 2 par semaines. Quel diagnostic retenez vous ?

Cas n°2

A) Migraine épisodique sans aura

B) Migraine chronique favorisée par la contraception

C) Céphalées de tension d'origine cervicale

D) Céphalées symptomatique d'un processus expansif

E) Trouble fonctionnel

Cas n°3



Critères diagnostiques de la migraine sans aura définis par l'International Headache Society (IHS)



Cas n°1

Cas n°2

Cas n°3

A - Au moins **5 crises** répondant aux critères **B à D**

B - Crises de céphalées durant de **4 à 72 heures** (sans traitement)

C - Céphalée ayant **au moins deux** des caractéristiques suivantes :

1. Localisation **unilatérale**.
2. Caractère **pulsatile**.
3. Intensité modérée ou **sévère**.
4. **Aggravation par les activités** physiques de routine.

D - Durant la céphalée, **au moins l'un** des caractères suivants :

1. **Nausées** et/ou vomissements.
2. **Photophobie et phonophobie**.

E - *L'histoire, l'examen physique et neurologique ne suggèrent pas une céphalée symptomatique.*



Critères diagnostiques des céphalées de tension définis par l'International Headache Society (IHS)



Cas n°1

Cas n°2

Cas n°3

- A. Au moins 10 épisodes de céphalées remplissant les critères.
Nombre de jours de céphalées <180/an (**<15j/mois**)
- B. Céphalées durant de 30 minutes à 7 jours
- C. La douleur comporte au moins 2 des caractéristiques suivantes :
 - à type de pression ou de serrement (**non pulsatile**)
 - légère à **modérée** (*peut gêner les activités, non les empêcher*)
 - localisation **bilatérale**
 - **pas d'aggravation** lors des activités physiques de routine
- D. Les deux caractères suivants:
 - pas de nausées ou de vomissements
 - pas de photophobie ni de phonophobie (*ou seulement l'un des 2*)
- E. *Absence d'arguments pour une céphalée secondaire*

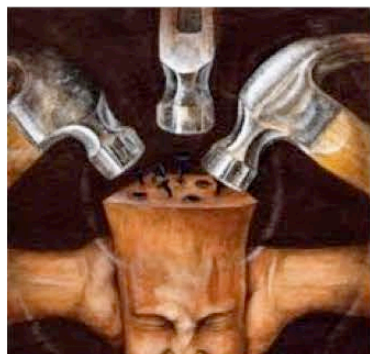


Migraine vs céphalées de tension



Sémiologie en miroir

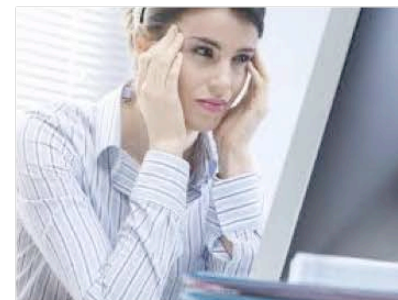
Cas n°1



Cas n°2



Cas n°3



Céphalée positionnelle



Cas n°1

Mme R., âgée de 25 ans, aux antécédents de migraine ayant disparu pendant la grossesse, a accouché d'un premier enfant une semaine plus tôt. Tout s'est parfaitement déroulé, mais depuis trois jours, des céphalées progressivement croissantes sont apparues, intéressant l'ensemble du crâne, non pulsatiles, et survenant électivement lorsqu'elle se lève et disparaissant après 15 minutes de décubitus. Il peut s'y associer des nausées. L'examen neurologique est sans particularité, et l'on relève l'absence de fièvre. Que suspectez vous ?

Cas n°2

- A) Résurgence des migraines en post-partum
- B) Hypertension intracrânienne liée à la montée de lait
- C) Hypotension intracrânienne d'origine iatrogène
- D) Thrombophlébite cérébrale du post-partum
- E) Post-partum blues

Cas n°3



Céphalée positionnelle



Cas n°1

Mme R., âgée de 25 ans, aux antécédents de migraine ayant disparu pendant la grossesse, a accouché d'un premier enfant une semaine plus tôt. Tout s'est parfaitement déroulé, mais depuis trois jours, des céphalées progressivement croissantes sont apparues, intéressant l'ensemble du crâne, non pulsatiles, et survenant électivement lorsqu'elle se lève et disparaissant après 15 minutes de décubitus. Il peut s'y associer des nausées. L'examen neurologique est sans particularité, et l'on relève l'absence de fièvre. Que suspectez vous ?

Cas n°2

- A) Résurgence des migraines en post-partum
- B) Hypertension intracrânienne liée à la montée de lait

Cas n°3

C) Hypotension intracrânienne d'origine iatrogène

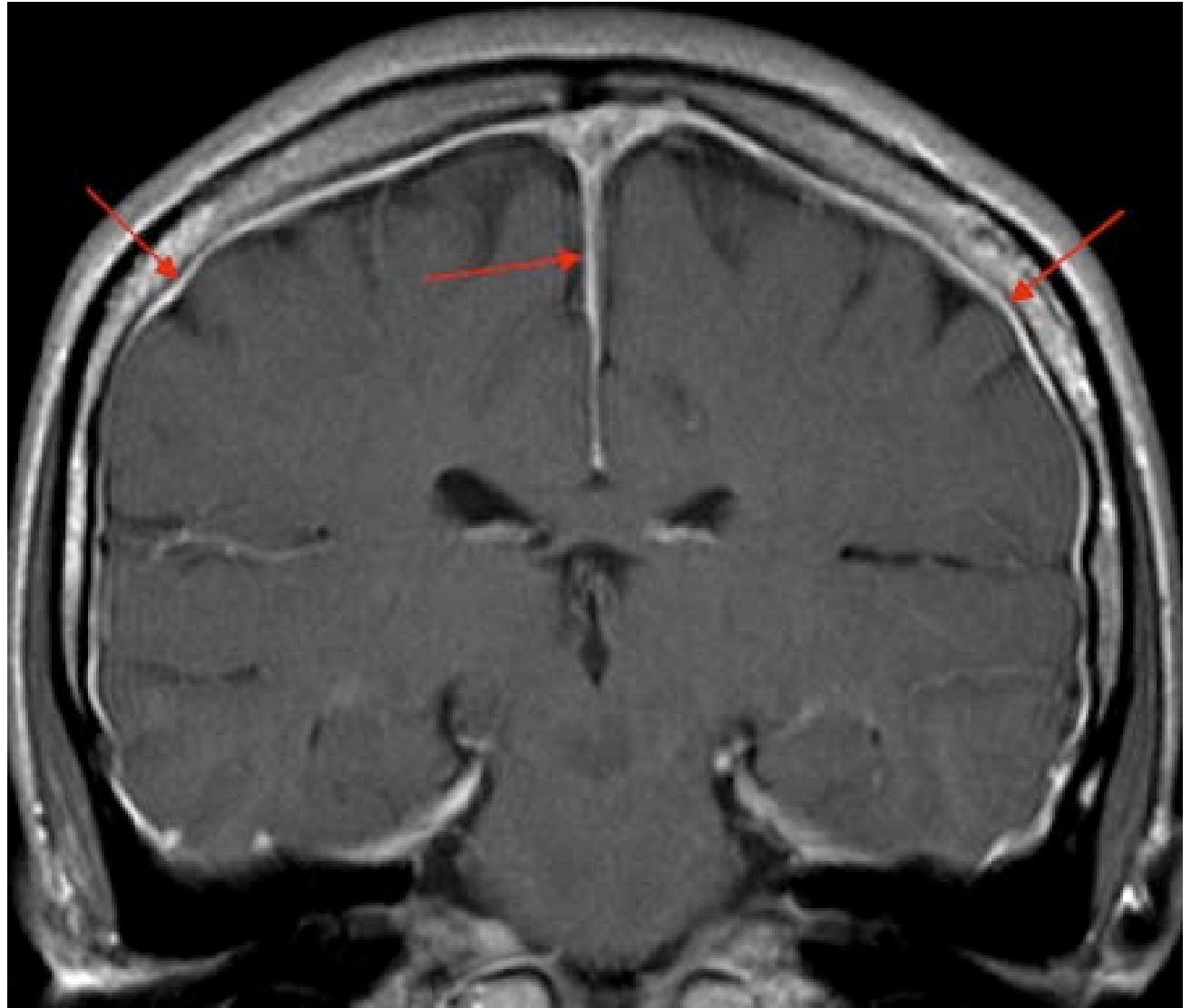
- D) Thrombophlébite cérébrale du post-partum
- E) Post-partum blues

Hypotension intracrânienne

Cas n°1

Cas n°2

Cas n°3

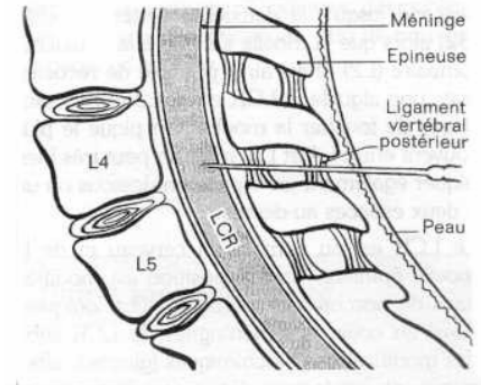
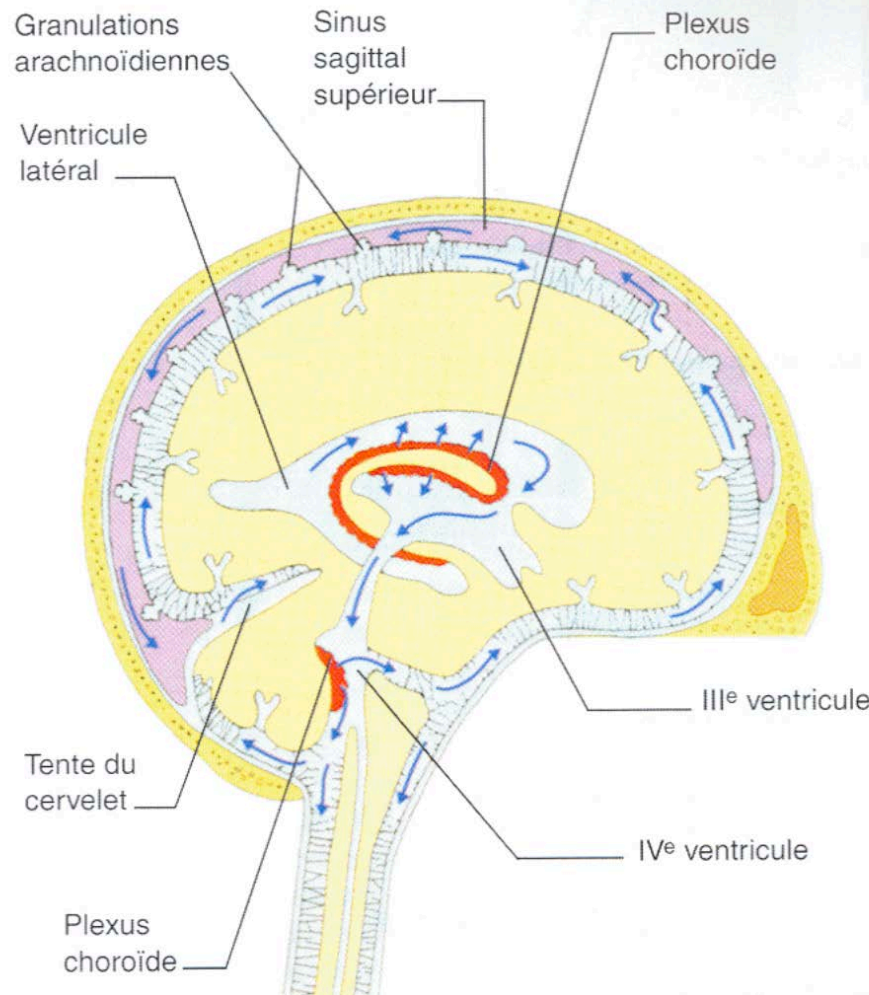


Hypotension intracrânienne

Cas n°1

Cas n°2

Cas n°3



Pression d'ouverture < 6 cm d'eau